トラウマ
傷

2026.02.22

受け流せないなにか。

起りうること

その場に立つまでが大変なのだ。そこから始めるのが大変なのだ。

その場に居ないようにする。自分の存在を消すこと、言質を受けないように。約束、死守、記憶の形成。

集合体としての動きに対して、無になること。倫理道徳の形成。弱い自我の形成、忘れられた自己、関係性によるという考えの根付き。想起のクセ、思考による逃避。

もう少し外傷性障害について書いておきたい。

PTSD 概念には DSM 体系の一部としての自己限定があり、従って、PTSD 概念ははみ出るもの、越えるものがあって当然である。PTSD 概念は精神医学を停滞させるためにでなく、さしあたっては整序するためであり、やがては越えられるためにある。

その第一は、生物学的方向であって、それは今さかんに行われつつある。DSM-V はこれに軸足を移すことを目標としている。

第二は、心理学的方向であり、最後は社会学的方向である。

まず心理学的方向に越えるとどういう世界が見えてくるであろうか。

私が「ああそうだ」とその世界を生で感じたのは、犯罪被害死を遂げた人の家族たちとの会合である。犯罪被害者支援の集まりの後の夕食会であった。被害者家族たちの食卓には他の誰も座っていない。一席だけ空いているところに私は座った。

その卓だけ明らかに何かが違っていた。新たに被害者になった人たちに対して長く被害者家族でありつづけていた人たちが話しかけていた。今のあなたがたは自分たちがとおってきた道の初めのほうにいる、時間だけが救いだ、被害者同士しかわかりあえない、などなど。

それはしめやかな雰囲気などでは全然なかった。家族たちは大声で語り、笑い、ビールの杯を重ねた。それと語る内容との大きな開きが異様であった。それが呼吸に努力を要するほどの「空気の薄さ」を生んだ。隣の卓の学者同士の談話が遠い遠いものに聞こえた。

それは「基本的信頼」を失った痛痛しい傷跡だった。ふつう、行きあう人間は何ごともなく行きあう。私たちの日常である。たいていはそれで済むのだが、それがいきなりそうでなくなった人たちである。それからその後に来るもの。世界全体ががらりと変わる。

考えてみれば、私たちの「基本的信頼」には根拠がない。「そういう保証があるか」というのは、議論に

おいて相手の言葉を詰まらせる必殺の技である。神さえそういう保証はしない。私たちは、大地に「揺るがないもの」という基本的信頼を置いて道を歩き、家を建てている。このいわれない仮定が覆ったのが震災被災者である。大西洋岸でのリスボンの地震が、この世はありうる世界の中の最善の世界であるという十八世紀西欧の楽観論哲学をくつがえしている。

いくつかの無根拠な基本的信頼にもとづいて私たちは生きている。物理的世界の恒常性も、私たちの心身の健康も、社会的基盤の確実さも、人人の善意も、実際は、それは私たちがお互いに生きてゆくことを可能にしている仮定にすぎない。それが無根拠・無理由のいわれのない基本的信頼である。これを疑うことは「杞憂」といわれ、たいていはそれで済む。

それは確率の問題である。そして、私たちの寿命の短かさが、重大な犯罪被害に遭う確率、地震、洪水、噴火などに遭う確率を少なくしている。一般に私たちの寿命が短いために運が不平等なのだといえるだろう。無常感は一世にして多くを味わった戦乱の中世に生まれた。

しかし、それは第三者の立場に立っての言説である。当人たちも、わが身に起こるまでは「ひとごと」であった、犯罪被害者で、「それまではひとごとと思っていたからバチが当たったのだ」と感じておられる方もあった。わが身に起こってはじめて、起こったことは取り消せず、失ったものと時間が呼び戻せないことを身を以て味わう。それは人生の不条理と知り、理不尽を知る「実存的」体験である。

不条理の最大は死であるが、私たちが死期を知りえないために死はひとごととなっている。戦場でさえ、ある旧海軍の掃海艇長は「自分は死なない」という確信の下に生きていたと私に語った。私たちの「希望」はしばしば不確定な将来の先送りである。だから希望を奪われている死刑囚だけにはこの基本的信頼がない。死刑という刑罰の核心はそれかもしれない。

PTSD はよく言われるように「通常の防衛規制によっては対処しえない」激甚な障害であろうか。最初から別のチャンネルによるものであろうか。通常の神経症には、さほどの原因的な事象が見当たらない。症状は長期にわたる潜伏期を経て現れ、非常に加工されていて、原因は非常に仮説的である。カーディナーがいう「戦争神経症」は「平和時神経症」とは違って直後から始まることが多く、（彼の言葉では）象徴化されず、最初からむきだしである。記憶も夢も戦闘シーンとその変奏を繰り返し再現し、それを思わせる状況を忌避する。特に初期は無構造な感情の渦巻であって、慢性化の過程で「構造化」され、心気的、抑鬱的、爆発的などになると彼はいう。人格を変えるに近いといってよいであろう。どこかに「降伏点」ともいうべき、心が弾性をうしなう一点があると考えられる。

PTSD（障害）と PTSR（反応）とを区別する一線があるとすれば、それは、次第に薄らぎ、忘却するという通常のコースにはいるか、そうでないかであろう。両者の差は時間とともに鋏状に拡大するはずだ。記憶のコースには「忘れるのを苦しむ」のと「忘れえない」のを苦しむのと二種類がある。前者は通常の記銘であり、記銘にも忘却にも健康な選択原理が働いている。後者は幼児記憶における刷り込みに近い。特に慢性外傷の治りにくさは、刷り込みを強制的に反復させるという、天然にはありえないような事態ゆえであろうか。

外傷性障害の社会性は卑近なところにある。天災による障害は、忘却される時が危機であるとラファエルはいう。戦争神経症は、急性期に「温かい食事と休息」を三日間与えるだけで相当部分は回復するとカーディナーはいう。これは忘れられていないということのあかしである。日本人なら「入浴」を加えたいところである。災害救援者の心的外傷から犯罪被害者まで、一般にピア・カウンセリングが重視されるのも、同じ機微である。逆に、孤独でないことを実感し、体験をわかちあい、生活再建が緒につく時、経過は順調に向かう。重症化を防ぐ意味での「二次予防」は社会的方法が主力であると言ってよかろう。一九九五年一月の神戸において、全国からの救援が目に見える形で与えられたことは、強力な二

次予防となった。おそらく、持続的被害の治療の困難性は、なによりもまず、社会性の慢性的剥奪にある。なるほど、基本的信頼は無根拠であるが、基本的不信もまた無根拠である。外傷においては実存的側面と社会的側面とは相互に接近しているように思う。

中井久夫『徴候・記憶・外傷』「あとがき」